

2

骨髄抑制・発熱性好中球減少症

感染リスクの管理と早期対応

1 起こりやすい薬剤とnadirの目安



細胞障害性抗がん薬全般で高頻度。特にアントラサイクリン系・タキサン系は好中球減少が強い



nadir(好中球最低値)は投与後7～14日目が目安、その後3週間前後で回復することが多い

2 発熱性好中球減少症(FN)の定義

好中球数500/ μ L未満(または1000/ μ L未満で48時間以内に500未満が予想される)+ 腋窩温37.5℃以上(口腔温38.0℃以上)の発熱 = FNとして緊急対応が必要

3 患者さんに伝える観察ポイント



37.5℃以上の発熱(悪寒・戦慄を伴うことも)



のどの痛み・口内炎・排尿時痛など感染を疑う症状



人混みを避ける・手洗い/うがい・生ものを避ける等の基本的な感染予防



nadir時期(投与後1～2週間)は特に体調変化に注意する時期であることを伝える

4 薬剤師のチェックポイント

- ☐ G-CSF製剤(フィルグラスチム・ペグフィルグラスチム等)の適応・投与タイミングを確認する
- ☐ 高リスクレジメンでは一次予防的G-CSF投与の要否を処方内容から確認する
- ☐ 発熱時は自己判断で解熱剤のみで様子を見ず、速やかな連絡・受診を指導する
- ☐ 血液検査値(特に好中球数)のタイミングと投与スケジュールの整合性を確認する

発熱性好中球減少症は数時間の対応の遅れが重症化に直結しうる。「発熱=すぐ連絡」を患者さんに徹底してもらうことが最大の予防策。